

18 - 01- Le Trouble Panique (TP) - Pr. LAFFINTI

(0:01 - 0:40)

Bonjour chers étudiants, j'ai le plaisir de vous enseigner un certain nombre de cours de pathologie psychiatrique, et nous allons commencer aujourd'hui par le trouble panique, qui est l'un des troubles anxieux. Pour introduire ce cours, nous allons commencer par quelques définitions. Et on commence d'abord par l'anxiété, qui correspond à une émotion physiologique, que chacun de nous a dû expérimenter ou expérimente pratiquement chaque jour devant des situations de menace ou de danger.

(0:41 - 1:30)

Elle joue alors un rôle adaptatif et peut être considérée comme étant normale, et nous permet d'être vigilant face à ces situations. L'anxiété peut devenir pathologique lorsqu'elle devient inadaptée, devient excessive et disproportionnée par rapport à la situation ou par rapport au facteur déclenchant. L'attaque de panique, appelée également crise aiguë d'angoisse ou crise d'angoisse aiguë, correspond à une montée paroxystique de l'anxiété qui va atteindre son acme en quelques minutes et qui va se traduire cliniquement par des manifestations diverses qu'on va voir plus tard dans ce cours.

(1:33 - 2:44)

Le trouble panique, proprement dit, peut être défini par la survenue d'attaques de panique qui sont récurrentes et inattendues, classiquement on parle de plus de 4 attaques par mois, dont au moins une de ces attaques doit être accompagnée sur une période d'un mois ou plus par une crainte persistante d'avoir une nouvelle attaque de panique ou par des préoccupations sur les conséquences éventuelles d'une attaque de panique ou par une modification du comportement du sujet qui est en rapport avec ces attaques de panique. L'intérêt de cette question, de ce cours, tient du fait qu'il s'agit d'un trouble fréquent, notamment en consultation de médecine générale et dans les services des urgences. C'est un trouble souvent méconnu parce que la symptomatologie physique est généralement au premier plan et les patients consultent souvent pour cette symptomatologie physique.

(2:45 - 3:28)

C'est un trouble dont les comorbidités sont fréquentes, notamment les autres troubles anxieux, la dépression, la vie de substance, et également parce que c'est un trouble dont le traitement est actuellement codifié et dont les résultats sont généralement insatisfaisants. Sur le plan épidémiologique, la prévalence du trouble panique dans la population générale est de 1 à 3%. L'enquête nationale réalisée en 2003 au Maroc a trouvé une prévalence de 6,6%.

(3:30 - 3:59)

L'âge de début généralement, le début de l'âge adulte entre 20 et 30 ans, c'est un trouble qui touche deux fois les femmes que les hommes. Certains facteurs de risque correspondent à des séparations ou à des situations de divorce ou chez les personnes de bas niveau socio-économique. Certains facteurs sont considérés comme facteurs déclenchant notamment les événements de vie pénibles.

(4:06 - 4:54)

L'étude clinique du trouble panique passe d'abord par la description de la clinique de l'attaque de panique, qui en constitue l'élément clé. L'attaque de panique correspond à un épisode paroxystique d'anxiété qui est délimité dans le temps, qui se traduit par une crainte et un malaise intense dont le début est souvent brutal et imprévisible, parfois un début nocturne sans facteur déclenchant apparent. Cette anxiété va atteindre son maximum en moins de 10 minutes et va durer entre 15 et 30 minutes pour céder progressivement au bout d'une à deux heures.

(4:55 - 5:22)

Elle dépasse rarement les deux heures. Elle va laisser place à un sentiment de soulagement et d'asthémie. La clinique de l'attaque de panique va se traduire à la fois sur le plan somatique que psychique et comportemental.

(5:24 - 5:59)

Sur le plan somatique, tous les appareils du corps peuvent être intéressés. Sur le plan cardiovasculaire, on peut avoir des précordialgies, des palpitations, l'hypothémie carrément, une instabilité artérielle. Sur le plan pulmonaire, les patients rapportent une gêne respiratoire, une toux nerveuse, une sensation de souffle coupé ou une sensation d'étouffement et d'étranglement avec une oppression thoracique.

(6:03 - 6:24)

Sur le plan digestif, les patients rapportent une sensation de boules oesophagiennes, de barres gastriques. On peut avoir une modification du transit intestinal, des diarrhées motrices ou des nausées, des vomissements. Aussi, les patients rapportent une impériosité, une prolacurie sur le plan généto-urinaire.

(6:24 - 7:25)

Sur le plan neuromusculaire, on peut avoir des céphalées, des vertiges, des tensions au secours musculaire, une sensation de fatigabilité ou carrément des douleurs articulaires. Sur le plan neurovégétatif, plusieurs symptômes peuvent être décrits comme une sensation de bouffée de chaleur ou de froid, une froideur des extrémités, une sécheresse de la bouche et des sueurs sont également rapportés par les patients. L'attaque de panique va s'accompagner sur le plan

psychique par un certain nombre de symptômes, notamment une peur mal définie et un sentiment de malaise intense.

(7:26 - 8:36)

Certains patients vous décrivent un sentiment de mort ou de catastrophe imminente, avec une peur d'avoir une crise cardiaque, une peur de mourir ou de devenir fou ou de perdre le contrôle. Parfois, cette peur est tellement importante qu'elle va donner lieu à des troubles de la perception de son corps ou de l'environnement, qu'on appelle un sentiment de déréalisation, avec un sentiment que l'environnement devient étrange, menaçant et perd son caractère familier, ou un sentiment de dépersonnalisation, un sentiment de ne plus être soi-même ou de ne plus se reconnaître. Sur le plan comportemental, l'attaque de panique va se traduire chez certains patients par une immobilité, où le patient se sent incapable de bouger, voire complètement sidéré.

(8:37 - 9:17)

Mais la plupart du temps, chez la plupart des patients, cette attaque de panique va se traduire par une instabilité, où le patient est complètement instable, multiplie les va-et-vient, va se rendre à l'extérieur, va ouvrir les portes de sa maison pour chercher de la fraîcheur, chercher de l'air. Certains vont se rendre chez des voisins pour chercher de l'aide ou se rendre d'urgence à l'hôpital. D'autres vont adopter des comportements d'automédication de façon abusive, des substances tranquillisantes.

(9:18 - 10:16)

Au maximum, cette instabilité va atteindre un degré d'agitation désordonnée, dont le risque est un passage à l'acte impulsif, irréfléchi, qui peut avoir des conséquences fâcheuses en termes d'auto- ou d'hétéro-agressivité qu'on appelle un raptus anxieux. Ces attaques de panique qu'on vient de décrire vont se reproduire chez les patients selon un rythme et une fréquence variables d'un patient à un autre. Ça peut aller d'une à deux attaques par semaine jusqu'à plusieurs attaques de panique par jour chez certains patients dans les formes les plus sévères.

(10:18 - 10:42)

Entre ces attaques de panique, le patient va développer d'autres manifestations cliniques qui sont moins intenses mais qui sont plus durables dans le temps. C'est ce qu'on appelle l'anxiété anticipatoire. Cette anxiété anticipatoire correspond à la crainte de voir se reproduire une nouvelle attaque de panique.

(10:42 - 11:32)

Le patient va avoir cette crainte anticipatoire de voir se reproduire une nouvelle crise d'angoisse, notamment dans certaines situations particulières. Le patient aussi va être préoccupé par les

conséquences éventuelles et les implications d'une attaque de panique dans des situations particulières, comme la conduite de véhicules, comme le fait d'être dans une file d'attente ou dans un transport en commun. Le sujet va adopter un changement du comportement et des stratégies afin d'éviter au maximum ces endroits ou ces situations où une attaque de panique pourrait survenir et avoir éventuellement des conséquences négatives.

(11:33 - 13:07)

Ce comportement d'évitement peut aussi s'associer à un autre comportement, ce qu'on appelle un comportement de réassurance, où le patient va adopter un comportement de... Sur le plan étiopathogénique, il y a plusieurs hypothèses dans la genèse du trouble panique. Sur le plan neurobiologique, on suppose un dérèglement ou une hypersensibilité des chémorécepteurs centraux aux variations de pH et de CO₂. Il y a aussi une théorie de la neurotransmission, notamment un excès de transmission noradrénergique et un déficit sérotoninergique, qui est appuyé par l'effet des médicaments et des antidépresseurs sérotoninergiques et noradrénergiques.

(13:09 - 13:51)

Aussi, il y a l'hypothèse du système de l'acide gamma-amino-butérique, notamment une diminution des récepteurs cérébraux ou benzodiazépines qui sont couplés aux récepteurs du gamma. On suppose aussi un excès de la neurode peptide, la cholécystokinine, qui aurait des effets paniquogènes. Pour la théorie génétique, elle est suggérée devant un risque plus élevé si les parents de premier degré ont un trouble panique et par un taux de concordance plus élevé chez les jumeaux homozygotes.

(13:54 - 14:32)

Concernant la théorie comportementale-cognitive, elle évoque plusieurs modèles, notamment le modèle des fausses alarmes, où il y aurait une sensibilité chez ces patients aux sensations internes, aux modifications physiologiques qui vont être interprétées de façon catastrophique. On parle d'une phobie intéroceptive. Cette interprétation catastrophique des sensations physiologiques internes vont accentuer l'anxiété.

(14:33 - 14:55)

Déjà, l'anxiété va donner ces sensations internes qui vont être interprétées de façon catastrophique. Elles vont augmenter encore plus l'anxiété et on va entrer dans un cercle vicieux où l'anxiété va être entretenue. Le plan évolutif.

(14:56 - 15:24)

En l'absence d'un traitement adapté, l'évolution se fait de façon chronique et peut se prolonger

sur plusieurs années. Et en présence d'un traitement adapté, on va assister à une réduction en termes de nombre et d'intensité des attaques de panique. Généralement, environ 40% des sujets vont être en rémission.

(15:26 - 15:48)

Et pour le reste, l'évolution se fait de façon plus fluctuante, avec persistance de quelques symptômes malgré un traitement adapté. Concernant les complications du trouble panique, c'est essentiellement un retentissement socio-professionnel. En termes d'indisponibilité, de qualité de vie.

(15:49 - 16:30)

C'est aussi l'apparition d'une dépression, une des complications les plus fréquentes, qui va majorer un risque de passage à l'acte suicidaire. La comorbidité est fréquente en termes de troubles paniques, notamment en association avec les autres troubles anxieux. L'une des complications aussi, c'est l'abus et la dépendance au benzodiazépine, au tranquillisant et à l'alcool comme moyen anxiolytique.

(16:32 - 16:48)

Automédication. Nous arrivons au chapitre du traitement, qui consiste en un traitement d'urgence. C'est un traitement de l'attaque de panique, qui est une urgence psychiatrique.

(16:49 - 17:11)

Et le traitement du trouble panique proprement dit. Pour l'attaque de panique, il faut d'abord éliminer toute cause organique par un examen complet, par les bilans qu'on vient de citer tout à l'heure. Et l'attitude à adopter face à une attaque de panique, c'est d'abord, en première intention, un abord relationnel.

(17:11 - 17:20)

Il faut faire sortir la famille et les tranquilliser. Il faut isoler le patient et le mettre au calme. Et le rassurer.

(17:20 - 17:33)

Lui expliquer l'origine psychique de ses symptômes. Et lui rappeler qu'il n'y a pas de menaces vitales. Et que la crise va cesser d'elle-même.

(17:33 - 17:51)

Et qu'il faut défocaliser son attention sur les sensations internes. Il faut aussi essayer d'éviter une hyperventilation qui va aggraver l'hypocapnie. Et aggraver les symptômes physiques.

(17:51 - 18:13)

On peut se faire aider par une respiration dans un sac de papier. Pour lutter contre cette hypocapnie. Ces mesures, cet abord relationnel permet de faire céder la crise d'angoisse dans la majorité des cas.

(18:14 - 18:30)

Mais si ce n'est pas le cas, on peut se faire aider par des médicaments d'urgence. Notamment des benzodiazépines par voie orale ou sublinguale. Notamment de l'alprazolam de 0,5 au 0,25 milligramme.

(18:30 - 18:56)

Pour faire céder cette anxiété si l'abord relationnel ne marche pas. La voie intramusculaire est à proscrire à l'essai en cas d'agitation majeure avec impossibilité de prise orale. Cette prescription anxiolytique doit être limitée dans le temps.

(18:56 - 19:08)

Pour éviter une éventuelle dépendance. La prise en charge généralement se fait en ambulatoire. Pour la crise d'angoisse et même pour le trouble panique.

(19:09 - 19:24)

L'hospitalisation est exceptionnelle. Elle est réservée en cas de risque de passage à l'aide. Ou en cas d'autre comorbidité qui peut justifier une hospitalisation.

(19:28 - 19:40)

On arrive maintenant au traitement du trouble panique constitué et proprement dit. Le traitement fait appel à des traitements pharmacologiques et psychothérapiques. Concernant le traitement pharmacologique.

(19:41 - 19:53)

Il se base essentiellement sur les antidépresseurs qui sont le traitement de fond. On a plusieurs classes thérapeutiques. Les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine sont à prescrire en première intention.

(19:54 - 20:06)

Cela nécessite généralement des posologies supérieures à celles recommandées dans la dépression. Un à deux voire trois comprimés par jour. Plusieurs molécules sont à notre disposition.

(20:07 - 20:16)

Comme la paroxythine, la mesitaloprale, etc. On a aussi les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline. Comme l'avait la vaccine.

(20:18 - 20:38)

Les tricycliques sont moins utilisés en première intention. En raison des effets secondaires plus marqués. Le traitement antidépresseur doit débiter de façon très progressive.

(20:38 - 20:49)

On commence par un demi-comprimé par jour. Pour éviter une recrudescence onctueuse notamment au début du traitement. Qui peut faire arrêter le traitement par le patient.

(20:50 - 21:00)

Et on passe la deuxième semaine à un comprimé par jour. Et si la réponse est insuffisante. On peut augmenter la posologie à deux voire trois comprimés par jour.

(21:00 - 21:10)

Le délai d'action du traitement antidépresseur dans le trouble panique. Est de six à huit semaines. Ce délai doit être expliqué au patient.

(21:10 - 21:21)

Pour qu'il n'arrête pas son traitement de façon intempestive. Le traitement instauré doit aussi être surveillé. On surveille son efficacité.

(21:21 - 21:32)

Mais aussi ses effets secondaires éventuels. Ses effets sont généralement passagers et minimes. Le traitement peut être prolongé de 12 à 18 mois.

(21:32 - 21:44)

La durée totale du traitement est de 12 à 18 mois. C'est un traitement de plusieurs mois. Qui peut être prolongé au delà de cette période dans certaines formes.

(21:45 - 22:07)

L'arrêt du traitement se fait de façon progressive. Pour éviter d'éventuels signes de sevrage. A côté du traitement de fond.

(22:08 - 22:18)

Qui se base sur les antidépresseurs. On peut avoir besoin d'un traitement adjuvant. Notamment dans les premières semaines du traitement.

(22:20 - 22:31)

On peut avoir besoin d'un traitement anxiolytique. Si les crises d'angoisse sont fréquentes. Et en attendant le délai d'action de l'antidépresseur.

(22:31 - 22:43)

On peut prescrire un anxiolytique type Alprazolam. De façon rapidement dégressive. Pour éviter toute dépendance.

(22:44 - 22:53)

On peut aussi avoir besoin d'un néptotique. En cas de problème de sommeil ou d'insomnie. Notamment dans les premières semaines.

(22:54 - 23:11)

Type Zolpidem, Stilnox, comprimé ou couché. A côté du traitement pharmacologique. Il y a aussi le traitement psychothérapeutique.

(23:11 - 23:21)

Qui se base essentiellement sur les techniques. De psychothérapie cognitive et comportementale. Ce sont des techniques codifiées.

(23:21 - 23:31)

Qui sont réalisées par un thérapeute. Formé à cet effet. Ce sont des techniques structurées.

(23:31 - 23:43)

Dont les résultats sont satisfaisants. Selon un schéma d'une vingtaine ou vingt-cinq séances. Réparties en une à deux séances.

(23:44 - 23:54)

D'une à deux heures par semaine. Le principe des techniques comportementales. Consiste en un apprentissage du contrôle de la respiration.

(23:55 - 24:07)

Pour éviter cette hyperventilation. Qui accentue l'anxiété et les symptômes physiques. Un apprentissage à la relaxation.

(24:08 - 24:17)

Mais aussi à une exposition. Aux sensations intéroceptives. Avec un essai de désensibilisation progressive.

(24:18 - 24:28)

Des fois on provoque ces symptômes. Et on aide le patient à ne plus réagir de la même façon. Face à ces symptômes ou ces sensations internes.

(24:29 - 24:37)

L'approche cognitive quant à elle. Consiste en une restructuration. Des croyances et un changement.

(24:37 - 24:51)

Des interprétations catastrophiques. Que les patients ont par rapport à leurs sensations internes. Aussi on conseille des mesures hégiéno-diététiques.

(24:51 - 24:59)

Tout ce qui est activité physique. Alimentation équilibrée etc. Le traitement du trouble panique.

(25:00 - 25:07)

Doit aussi prendre en compte. Des complications éventuelles. Notamment complications dépressives.

(25:07 - 25:21)

Ou les addictives éventuelles. C'est un traitement global. En conclusion.

(25:22 - 25:28)

Le trouble panique reste un trouble fréquent. En consultation de médecine générale. Et d'urgence.

(25:28 - 25:37)

Il est souvent méconnu. Du fait de la symptomatologie physique. Qui est généralement au premier plan.

(25:37 - 25:44)

Ce qui amène à une surconsommation. Du système de soins. Une errance entre les différentes

spécialités.

(25:45 - 25:50)

Avant de pouvoir poser le diagnostic. Du trouble panique. D'où le rôle capital.

(25:51 - 25:55)

Du médecin généraliste. Notamment dans la reconnaissance. De ce trouble.

(25:55 - 26:00)

Mais aussi dans la prise en charge. Des formes légères. Et modérées.

(26:01 - 26:06)

C'est le médecin généraliste. Normalement. Qui est capable de prendre en charge.

(26:06 - 26:13)

Ces formes modérées. Et légères. Et référer les formes sévères.

(26:13 - 26:17)

Aux spécialistes. Pour complément de prise en charge. Merci.